

DERMATOLOGIE

Dr.KHERBA_N

DERMATOLOGIE

Acné

Alopécie

Brûlures

Candidose cutanée

Chancre mou

Chéilite

Cicatrisation

Cors

Coups de soleil

Dermatite atopique

Dermatite de siège

Dermatite séborrhéique

Eczéma

Érythème polymorphe

Escarres

Fissures

Folliculite

Furoncle

Gale

Herpès circiné

Herpès labial

Impétigo

Intertrigo

Leishmaniose

Lichen plan

Lucite estivale

Molluscum contagiosum

Onychomycose

Onyxis Périonyxis

Panaris

Pédiculoses

Piqûres d'insectes

Pityriasis rosé de Gibert

Pityriasis versicolor

Prurigo

Prurit

Psoriasis

Rosacée

Scarlatine

Teignes

Ulcère de la jambe

Urticaire

Verrues

Acné

● Clinique :

Peau grasse avec présence des boutons..

Comédons papules pustules nodules kystes..

✓ Traitement selon la forme :

1 Les acnés légères à modérées=> un traitement local seul :

■ Si : lésions rétentionnelles :

Adapalène 1app/j le soir

■ Si : lésions inflammatoires localisées :

ATB local + POB

+/_ Skinoren

2 Les acnés papulo pustuleuses plus graves :

Doxycycline 100mg/j max 4mois

+ Traitement local : POB ou rétinoïdes ou les 2

■ Si : CI aux Cyclines => Erythromycine ou Gluconate du Zink.

3 Les acnés nodulo kystiques ou en cas d'échec d'un traitement par les Cyclines :

Isotrétinoïne 0.5mg/kg/j

Puis ↗ progressivement + Contraception stricte.

4 Femme avec acné modérée et demandeuse d'une Contraception orale :

Diane 35 + traitement local

- Bilan hormonal : 
- Gly jeûne
- FSH/LH
- TSH/T4/T3
- DHEA_S
- Prolactine
- Alpha 4 Androstenidione
- 17_OH_progésterone
- Testostérone total et libre
- +/- Echographie pelvienne



Alopécie

● Clinique :

Homme : fronto_temporale et vertex

Femme : vertex

✓ Traitement :

1 Minoxidil sol 7app de 1ml 2/j matin/soir pdt 2 mois

Femme 2%

Homme 2%.5%

2 Pantophil 5_7app 1/j 1tube

3 Phytohair gel 2gel le matin pdt 3mois

■ Shampooining :Provégol, Ducray extra doux, Argeal..

■Supplémentation en Fer , Vit D :

Vit D 1amp 200.000Ui chaque 15j

Neofer cp 1cp/j

■Bilan : 

■FNS

■Férritine

■TSH/T4

■Vit D/Ca

■B9/B12

■Bilan hormonal si Troubles de cycle=>

Echographie (SPOK) : au J2J3

■LH/FSH

■Testostérone

■Progestérone/Œstrogènes

■DHEA

■Cortisolémie

Brûlures

● Clinique :

■ 1^{er} degré : érythème isolé

Peau rouge, sèche, douloureuse, sans cloques.

Ex : coups de soleil. Cicatrisation en 4_6j.

■ 2^{ème} degré : phlyctène

Superficiel : rose ou hémorragique

Peau très douloureuse, rouge, gonflée, suintante, couverte de cloques contenant de liquide clair

Cicatrisation spontanée sans séquelles en 10_14j.

■ Profond : hétérogène=> rouge brune ou blanche

Peau sous les cloques blanches est pâle,
lésions peu sensible, épiderme et derme
superficiels sont détruits

Cicatrisation en 35j.

■ 3^{ème} degré :

Plaie brune ou noire, pas de cloques.

■ 4^{ème} degré :

La totalité de l'épiderme et derme, os, muscles
et nerfs sont atteints.

✓ Traitement :

■ Réhydratation : 4cc SSI/kg/j

1/2 dans les 8 premières heures

1/2 dans les 16 heures

$4 \times \text{poids} \times \text{surface brûlée} = \dots \text{ml}$

2/3 SSI 1/3 sérum Bicarbonaté

1 Flammazine pmd 1app 3/j 1tube

Avec l'intermédiaire d'un gaz stérile soit directement sur la lésion.

2 Doliprane 15mg/kg/6h Ou 1g 3/j chaque 8h

⊖ Flammazine est CI chez la femme enceinte et allaitante → Biafine ou Hydrocoll

Et en cas des brûlures chimiques

- ATB : pas systématique

- Si : surinfection, profonde, immunodépression

- Lexin 1g 1cp 2/j pdt 10j Ou Cefacet 1g 3/j pdt 7j

Ou Floxapen cp 500mg 1cp 3/j

- 1^{er} degré => Biafine ou Flammazine pmd

Flammazine 1app 2/j si risque d'infection

Si non Biafine

+/_ Mebo pour les cicatrices

Pansement chaque jour et Tulle gras chaque 2j

 Hospitalisation :

VVP/O2 thérapie/Scope

■ Bilan complet 

■ FNS

■ Glycémie à jeun

■ Urée/Créat

■ TGO/TGP

■ TP/TCK

■ Fibrinogène

■ Albuminémie

■ Ionogramme

A refaire après 48h

■ TLT + ECG

■ Réhydratation : 24h

SSI 4ml/kg/SB%/24h

½ en 8h et ½ en 16h

✓ Traitement :

1 Solumedrol 60mg en IV

2 Mopral 40mg en bolus IVD pour éviter l'ulcère de stress puis 40mg/24h

3 Lovenox 0.4Ui en Sc

4 Perfalgan voir Tamgésic

■ Enfant  :

 Hospitalisation

Réhydratation par SRH/6h pdt 48h IVL

Flammazine et Tulle gras

Cefacet 25_50mg/kg/6h en IVD

Protocole de 7j

Traitement de sortie après amélioration : Mebo
ou Biafine

⊖ Visage des nouveaux_né:

Biafine et Flammazine sont déconseillés

Soins au SSI ou Chlorhexidine aqueuse 0.05% +
Dexeryl

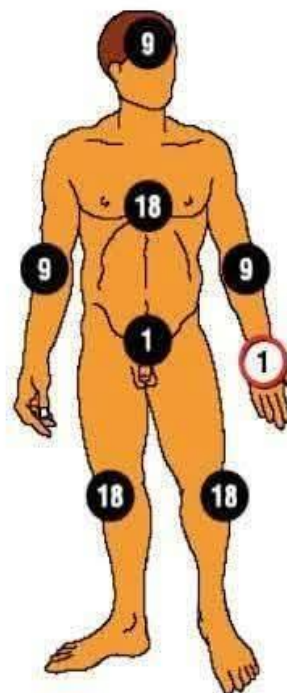
■ Soins pour les brûlures :

Nettoyage au SSI puis appliquer Mebo ou
Biafine pmd

Changement de pansement 1/2j.

Règle des 9 de Wallace

Localisation	Surface brûlée en % de surface corporelle
Tête et cou	9 %
Chaque membre supérieur	9 %
Chaque membre inférieur	9 % x 2
Tronc face antérieure	9 % x 2
Tronc face postérieure	9 % x 2
Périnée	1 %



Paume de la paume : 1 %



Chancre mou

● Clinique :

Maladie sexuellement transmissible,
ulcérations douloureuse + tuméfaction et
suppuration des ganglions

Sérologie

✓ Traitement :

1 Zomax cp 500mg 1cp/j pdt 3j

Ou Ciprolon cp 500mg 1cp/j pdt 10j

2 Betadine sol 1app 3/j 1flc

3 Paracétamol cp 1g 1cp/j



Chéilite Perlèche

● Clinique :

Inflammation au niveau du pli de la commissure des lèvres

Rougeur, croûte, saignement, Bilatérale +++

- Bilan :  rechercher une anémie
- FNS
- Ferritinémie
- Fer sérique
- CRP/VS
- Urée/Créat
- ECBU

✓ Traitement :

Fungizone cp 250mg 2cp 2/j 50mg/kg/j

Ou Fungizone sol 500mg

Ou Fungizone pmd/Mycostatine

■ Si échec :

Duflucan gel 50mg 3gel/j



Cicatrisation

● Pommades pour la cicatrisation :

- Chiroxy
- Cicavex
- Cicatryl bio
- Cicastim ACM
- Hyper oil
- Kelocote
- Lentiscia
- Leader max
- Madecasol
- Melaskare
- Mebo
- Seba med
- Sito heal
- Scarmed

Cors et Durillons

✓ Traitement :

- Semelles orthopédiques

1 Cornex ou Duofilm pmd 1app/j le soir pdt 1mois

Ou Vericide/Coricide urgo/Urgo cor/Verruxid/Kerafilm pmd 1app 2/j

Ou Steripan pansement 1app le soir après bain chaud

2 Vaseline salicylée 10% 1app 2/j 1bte

Vaseline autour de la lésion puis Cornex au centre

- Si non: Chirurgie → Cryothérapie

■ Diabétique: Coryos crème + Vaseline salicylée

⊖ Cornex et Urgo path (Corricides/Verricides)
sont CI chez le diabétique



Coup de soleil

● Même CAT que une brûlure de 1^{er} degré.

✓ CAT :

TA/T°/DEXTRO/SaO2

■ Bilan : 🩸

■ FNS

■ Urée/Créat

■ Ionogramme

✓ Traitement :

1 Biafine ou Mebo ou Biaficure ou Flammazine
1_2 app/j

2 Paracétamol 1g/6h si fièvre ou douleur

3 Ecran total/4h spf50 ou Dexeryl + vit C

Dermatite atopique

● Clinique :

Maladie cutanée prurigineuse, démangeaisons chroniques évoluant par poussées.

NRS et enfants +++

Plis de flexion => après 2ans

Convexité => avant 2ans

■ Bilan: 

■ FNS

✓ Traitement : Adulte

■ Poussées: Antiseptique + DCTC + Hydratant

■ En dehors des poussées: Bains quotidiens tièdes émoullients

■ ATB si surinfection

■ CTC par VO sont CI

■ AH

1 Hydracort 1tube

1app/j le soir pdt 1 sem

Puis 1app 1/2j pdt 1sem

Puis 1app 1/3 pdt 1sem

Ou Betacyl pmd

Pli suintante=> crème

Peau sèche =>pmd

Zone pileuse=> gel

1app 2/j pdt 5j

1app/j pdt 5j

1app/2j pdt 5j

Ou Bestasone pmd 0.05% 1app 2/j pdt 1sem
puis dégression

2 Histagan ou Primalan ou Deslor cp 1cp/j soir

Ou Clarityne cp 10mg 1cp/j

3 Topialyse lait 1 app 2/j

4 Vaseline 10% 1 app 2/j Ou Dexeryl

5 Hexomedine sol 1 app 2/j après bain

■ Enfant 🧒 :

■ Appliquer le lait maternel sur les lésions

1 Locapred pmd 0.17 la nuit

1 app/j pdt 7j

1 app/2j pdt 7j

1 app/3j pdt 7j

Puis arrêt

2 Primalan ou Histagan sirop 1càm 1/j la nuit

3 Dexeryl ou Parex ou Vaseline 1 app 3/j

■ Dermosone pmd=> pieds et mains

■ Locapred pmd=> plis génitale et NRS

■ Hydrocortisone=> visage



Dermatite de siège / Erythème fessier

Clinique :

Une irritation de la peau qui apparaît à l'endroit de la couche, notamment au niveau des fesses, des cuisses, de l'abdomen ou des organes génitaux.

Traitement :

- Changement fréquent de couche /3h
- Eosine aqueuse sol 1app 2/j

Après Désinfection :

- Oxyplastine pmd 1app 2/j

Ou Huile de foie HFM 1app 3/j

Ou Dermocuire pmd 1app 2/j

Ou Lactacyd pmd 1app 2/j

Bepanthen/Beprotect/Douce plus/Bébé Set/Bébé Zinc/Oxycare/Bébéthén/Cicap..

■ Si persistance :

Econazol lait 1 app 2/j

Ou Ketoderm pmd 1 app 2/j

Dermite séborrhéique

Clinique :

Dermatose inflammatoire cutanée fréquente

Plaques rouges, recouvertes de squames

grasses et jaunâtres, +/- prurigineuses,

prédominant dans les zones riches en glandes sébacées

CAT :

■ Visage => Mycoster crème

+ Dexeryl pmd

DermoCTC : Xaracalm AD pour Inflammation de visage pdt 5j

■ Surcils => Dexeryl crème

■ Cuir chevelu => Vaseline 2h puis rinçage puis brosser doucement

- Cuir chevelu de bébé:

Shampooing doux app tous les jours:

Klorane bébé/Mustella/Aderma primalba

- Si des croûtes épaisses: avant Shampooing:

Mustella Stelaker/Klorane gel/Avene pédiatril gel..

- Si c'est sévère: CTC topique:

Hydrocortisone 1% 2app/j Pdt 5j

Ou Antifongique local Imidazolé pdt 2_4sem



Eczéma

● Clinique:

Dermatose inflammatoire chronique
prurigineuse et récidivante

Phases: érythémateuse, vésiculeuse, croûtes
(suintement), desquamation

Produits cosmétiques, vêtements, profession..

Éviction de l'allergène qui permet la guérison

■ Antiseptique doux: KMnO_4 bain 1cp dans 5l

■ Asséchant: Violet de Gentiane

Bleu de Méthylène, Eosine aqueuse 2%

■ ATB local: Ac Fucidique 1app/j pdt 7j

Si surinfection

■ DermoCTC: soir

Clotasol++++, Betasone+++

=> Dose dégressive: 1_2/j pdt 5j puis 1/2j pdt 10j

Puis 1app 2/sem

Locapred++, Hydrocortisone (Corten), Pietal..

■ Hydratant: Vaseline pure 1app 3/j

Ou Dexeryl, Atopicalm..

■ AH: Polaramine/Atarax/Telfast 180mg 1cp/j

● Eczéma de contact / Dermatite atopique:

■ Traitement local:

- Poussée => Antiseptique + DCTC + Hydratant

- En dehors de poussée => bains quotidiens tièdes émoullients

- Asséchant sur le suintement

■ Traitement général:

- ATB si surinfection

- CTC sont CI

- AH

1 Bestasone pmd 0.05% 1 app 2/j pdt 7j puis dégression

2 Hexamedine sol 1 app 2/j 1flc après bain

3 Clarityne cp 10mg 1cp/j le soir

4 Dexeryl crème 1 app 2/j

1 Betacyl (CTC + Vaseline) 1_2 app/j pdt 5j

Puis 1 app/j pdt 10j puis 1 app 2/sem

Ou Diprosone + Vaseline

■ Visage: Locapred pmd

● Eczéma surinfecté: Rechercher une ID

1 Histagan 1cp 1/j le soir

Ou Deslor 5mg/ Xycare cp 5mg le soir

2 Pyostacine cp 500mg 1cp 3/j

Ou Fluconazole cp 150mg en 1seule prise

3 Soins locaux après application de Violet de Gentiane 2/j Ou Permanganate de K 1app 2/j pdt 20min Ou Dakin

▪ après 5j pmd microbienne 2%

Zeta cort pmd 1app 2/j Ou Fucidine pmd 1app 2/j

● Eczéma de l'oreille:

1 Diprosone pmd ou gtt 2gtt 2/j pdt 10j avec ↘

Ou Locapred

2 Zeta cort pmd 1app 2/j

● Nouveau_né 🍼

■ Préparation: Locapred crème 1% + Vaseline blanche 1app/j pdt 1sem puis 1app/2j pdt 1sem
Puis 1app/3j pdt 1sem

■ Si prurit: Primalan sirop 1cam/5kg/j

● Eczéma de visage nouveau_né: 🍼

Dexeryl crème 1app/j

Betasone 0.05% 1app/j le soir Ou Locapred



Érythème polymorphe

● Clinique:

- Lésions en cible, centre foncé périphérie claire
- Vérifier l'atteinte des muqueuses
- Rechercher une prise médicamenteuse, infection virale notamment HSV..

✓ Traitement symptomatique:

- 1 CTC en l'absence d'infection virale concomitante
- 2 Antihistaminique
- 3 Antiseptique
- 4 Emollient

- Si présence d'infection HSV : Antiviraux
- Si prise médicamenteuse récente: arrêt
- Contrôle après 1 semaine, si aggravation:
 - Orientation dermatologie



Escarres

Clinique :

Plaies cutanées provoquées par une mauvaise irrigation sanguine liée à une pression prolongée.

Traitement :

- Matelas antiescarres
- Changement de position/2h
- Hydratation
- Lavage au SSI
- Mebo scar crème

Ou Flamazole crème 1%/Coloplast/Hyperoïel
crème /Miel naturel

- Puis tulle gras
- Puis Coloplast pour une prévention

- Si pansement: selon les lésions

Humide: pansement alginate

Sec: Hydrocol

- +/- Nécroéctomie

⊖ Pas de Betadine → retarde la cicatrisation

- ATB si infection:

■ Lexin cp 1g 1cp 2_3/j pdt 10j Ou Cefacet Ou Augmentin

+ Flagyl

- Lovenox préventif



Escarres grade 3 ou 4 :

- Débridement de tissu nécrosé avec nettoyage abondant par SSI9%
- Attention jamais de détersion mécanique pour une plaie fibrineuse. Plutôt détersion chimique
- Pansement hydrocolloïde pour absorber la sérosité
- Rx si profond (rechercher une ostéite)

Traitement :

- 1 Fucidine cp 500mg 3/j
- 2 Ceftriaxone 1g 1/j en IM pdt 14j
- 3 Flagyl 500mg 3*j (pas systématiquement)
- 4 Vitamine C + D + Mg + Zinc essentiel pour la cicatrisation

- Pas d'antibiotiques locale dans ce cas
- Changement de pansement chaque jr au début puis 1j/2 (selon l'abondance de la sérosité)
- Application des pansements hydrocellulaires toutes les 48 et 72h
- Apport hydrique et protéique suffisant + cousin anti escarre et changement régulièrement de la position

■ Bilan pour évaluer l'état de la patiente :

■ FNS

■ CRP

■ Rénal

■ Hépatique

⊖ Contrôler la fièvre surtout et les constantes vitales (Si fébrile peut être un état de sepsis)

➞ Avis spécialisée

Fissures

✓ Traitement:

- Une séance de pédicure ou l'eau chaud avec sels chaque jour + grattage + chaussures orthopédiques
- Bon hydratation: boire +++
- Crème hydratante: Vaseline salicylée 10%
- Ou Dexeryl pmd
- Akaleine crème pied
- Aloeverra gel
- Cadence crème
- Si prurigineuse: mycose!

- Bilan: 
- FNS
- Ionogramme

- Glycémie à jeun (signes d'insulino résistance)



Folliculite

● Clinique :

Inflammation d'un ou plusieurs follicules pileux formant une papulo pustule=> zones pourvus du poils

✓ Traitement :

1 Hexomedine sol 1 app 4/j

Puis appliquer Fucidine pmd

- Si lésions étendues : Lexin cp 1g 3/j
- Arrêter le rasage et couper au ciseaux



Furoncle

Clinique :

Infection bactérienne profonde d'un follicule pileux provoquant la nécrose périfolliculaire et la suppuration

Il en résulte une induration douloureuse du derme causée par une accumulation de pus et du tissu mort.

- Bilan 
- Glycémie à jeun
- HBA1C

Traitement : Adulte

Lavage bi quotidien à l'eau et au savon

-  1 Fucidine pmd 1 app 2/j
-  2 Hexomedine sol 1 app 2/j + Betadine
-  3 Codolyc cp 1g 1cp 3/j

■ Furoncle surinfecté :

1 Lexinal 1g cp 1cp 2/j pdt 7j

Ou Cefacet cp 1g 1cp 3/j pdt 5j

Ou Augmentin St 1g 1st 2/j pdt 7j

2 Fucidine cp 250mg 2cp 3/j pdt 10j

Ou Fucidine pmd

Contrôle 48h

Échographie !

■ Enfant 🧒 :

1 Fucidine pmd 1app 2/j

2 Hexomedine sol

■ Surinfecté :

Lexin sirop pdt 7j



Gale

Clinique :

Prurit nocturne intense, lésions de grattage, vésiculo pustuleuses, sillon scabieux interdigitale et au niveau du pli du coude, pas de fièvre

Respect le visage

Nourrisson => palmoplantaire

Cas similaire dans l'entourage..

Traitement : Adulte

- Traitement de toute la famille !
- Couper les ongles

1 Ascabiol 25% lotion 2flc appliquer sur tout le corps sauf visage.

J1 : après un bain chaud 1^{ère} app 20min 2^{ème} app

J2 : 3^{ème} app sans Douche

J3 : Douche

Ou J3 : app sans Douche

J4 : app sans Douche

J5 : Douche

Ou Douche, séchage puis application pdt 24h
puis Douche en: J0J8J15

2 Aphtiria poudre ou Talc anti gale

Mettez la literie et vêtements dans un sac
occlus 3j puis lavez 60°

+/_ Antihistaminique : pdt 5j

+/_ ATB

Loratidine 10mg Ou Telfast 180mg 1cp le soir

Ou Eurax crème

■ Enfant  <2ans : mais à partir 1mois=> même que la femme enceinte

Ascabiol lotion 1 seule application de durée <12h

Après Douche et séchage

Deslor Ou Polaramine sirop 1cam/10kg à partir de 6mois.

■ Si Résistance à l'Ascabiol=> Ivermectine cp

Stromectol 3mg 4cp en prise unique VO
200ug/kg

■ A renouveler 2sem après si :

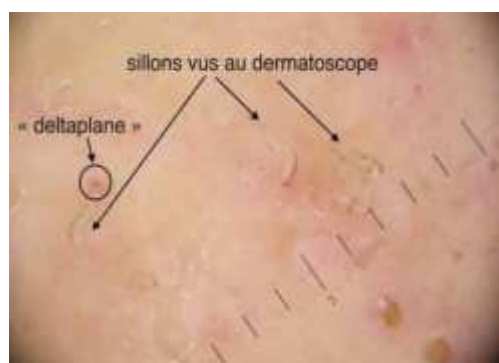
Nouvelles lésions spécifiques

■ Si <6ans : cp écrasé avant d'être avaler

2mois_24mois : Perméthrine crème 5%

■ Si échec => Ivermectine cp

<2mois : Perméthrine crème 5%



Herpès circiné

Clinique : Tenia corporis

Les lésions qu'engendre l'herpès circiné sont assez caractéristiques, elles forment un halo rouge au niveau de la peau. On parle de tâches en forme de « roue de Sainte-Catherine »

Traitement :

Rechercher une immunodépression !

■ Bilan : 

■ FNS

■ Gly

■ HBA1C

■ Forme étendue ou récidive : Traitement VO

⇒ Bilan hépatique + rénal

Terbinafine Ou Lamisil cp 250mg 1cp/j pdt 15j

Ou Fluconazole cp 150mg 1/sem pdt 3sem

■ Enfant 🧒 :

Griseofulvine 20mg/kg/j pdt 4sem

■ Forme minime : traitement local

Ketoconazole 2% ou Vavo crème 1app 2/j pdt 20_30j

Ou Pevaryl / Dermofix / Lamidaz / Lamisil 1%
1app 2/j pdt 21j

Isomedine sol 1app 3/j pdt 7j

■ Enfant 🧒 :

Terbinafine (Lamisil) 1% pmd 1app/j



Herpès labial / Bouton de fièvre

● Clinique :

Un bouquet de vésicules sur une lèvre. Il récidive fréquemment.

✓ Traitement :

1 Ciclovir pmd 1 app 4_5/j

2 Hexomedine sol 1 app 3/j

3 Paracétamol si fièvre

Ou Zovirax pmd 1 app 3/j jusqu'à la guérison

■ Si répétition :

■ Aciclovir cp 200mg 5/j pdt 5j

■ Bilan : 

■ FNS / Glycémie à jeûne

■ Sérologie

herpès labiale :



Impétigo

Clinique :

Infection bactérienne de la peau autour des orifices, couleur de miel=> éviction scolaire 5j

Début vésiculo_bulleuse puis évolue vers des croûtes jaunâtres mélicériques

En péri orifices +++ pas de signes généraux

Risque d'atteinte rénale :

- TA
- CU (3sem après l'épisode infectieux)
- Labstix

Traitement :

- Moins étendu :

 1 Fucidine ou Zeta pmd 1app 2/j pdt 10j

 2 Hexomedine sol 1app 3/j

■ Étendu :

1 Keforal sirop 125 250 1cam 2/j 50mg/kg/j pdt 10j

2 Fucidine pmd 1app 2/j pdt 10j

3 Hexomedine sol 1app 2/j pdt 10j

+/_ Paracétamol si fièvre

■ RHD : couper les angles

Lavage au savon

⊘ AINS sont CI



Impétigo Bulleux

● Clinique : Chez le nourrisson :

Agent causal : staphylocoques, qui secrète des toxines exfoliants A ou B

En absence du traitement, le toxine passe dans le sang responsable de syndrome de Ritter (epidermolyse staphylococique)

■ Examen clinique : signe de Nikolsky (fortement de la lésion permet de décoller facilement la peau)

■ Siège de lésion : généralement au niveau périanal et périgénital

✓ CAT :

■ Soins locaux par eau et savon et mesure d'hygiène (car il est contagieux)

■ ATB local (fucidine pmd 1app 3/j)

- ATB général : Augmentin 80mg/kg/j pdt 10j
- Si allergie : Josamycine 50mg/kg/j

■ Dans les formes bénignes : impétigo

En 1^{er} intention : Pyostacine cp pdt 10j chez l'adulte



Intertrigo

 Clinique :

Inflammation de l'épiderme due à l'humidité..

 Traitement :

Terbinafine/Lamisil/Vavo/Lamidaz/Dermofix/Pe
varyl/Ketoskin

Pmd 1app 2/j pdt 3mois

Ou Econazole crème 1% Ketokonazol crème

Ou Mycoster crème 1% 1app 2/j pdt 14_28j

Ou Mycocide pmd 1app 2/j

Dermobacter sol

Pevaryl spray

Betadine 1app 2/j

■ Si lésions étendues :

Terbinafine cp 250mg 1cp/j pdt 3mois après
bilan hépatique

Ou Fonginal cp 150mg 1cp/j

Ou Econazole cp 50mg 3cp par semaine pdt
4sem

■ Après toilette au dakin et surtout séchage.

🚫 Pas : Eosine aqueuse, CTC, talcs...

■ Enfant 🧒

Ketoderm 2% 1app/j pdt 21j

Intertrigo au niveau du cou 🧒

1 Phanazol pmd 1/j



Intertrigo interorteils

- Pevaryl lait 2% 1 app 2/j pdt 1 mois
- Econazole poudre pour stérilisation des chaussures et chaussettes
- Bien sécher les pieds 

Leishmaniose

- Ulcère creuseuse
- Papule rouge foncé
- Nodules mal limité, creusé au centre par une ulcération
- Croûte jaune brunâtre
- Régions découvertes, pas de douleur ni ADP +/- prurit.
- Vecteur : Phlébothome
- Diagnostic : examen directe au MO

Prélèvement de la lésion cutanée en dehors du pus

- Bilan pré thérapeutique : 
- FNS
- Rénal / Hépatique
- ECG
- TLT

✓ Traitement :

1 Cefacet cp 1g 1cp 2/j

2 Flagyl cp 500mg 1cp 2/j

3 Eau oxygénée app par compresse imbibée
pdt 2 min 2/j pdt 1mois

■ Si résultats (⊖+)=> Glucantime

■ Si 1 ou 2 lésions ailleurs que la face :

Glucantime 2,5 cc infiltration à un 1cm de la
lésion (au niveau des 4 points cardinaux) 2/sem
pdt 1mois

■ Si 3 lésions ou plus ou une lésion au niveau de
la face => Hospitalisation pour un traitement
par Glucantime en IM vu ses effets secondaires

Ou ■ <3 lésions non compliquées :

Eau oxygénée

Flagyl 500mg

Betadine

Rozax

■ >3 lésions ou évolutives :

Même Traitement + inj de Glucantime

2.5cc/lésion

⊘ Si la lésion est péri orificiel l'inj est CI

■ >3 lésions compliquées :

➡ Avis dermatologie



Lichen plan

● Clinique :

Maladie inflammatoire de peau et muqueuse

Papules polygonales violacées, prurigineuses

✓ Traitement :

1 Tabeta crème 1app/j pdt 10j

Puis 1app/2j pdt 10j

Puis 2app/sem

2 Allertine cp 10mg 1cp/j

3 Diprostène inj 1inj/21j 2btes



Lucite estivale

● Clinique: 2 Types:

- Bénigne: ne touche pas le visage
- Polymorphe (maligne): petites bosses rouges qui démangent sur la peau exposée au soleil, en particulier le visage, le cou, les avant-bras et les jambes. Elle apparaît généralement 30min à quelques heures après l'exposition au soleil et peut durer entre 1_14j

Prurigineuses +++

✓ CAT:

- Éviter l'exposition prolongée au soleil
- Utiliser un écran solaire avec un SPF 50 ou>
- Antihistaminique pour soulager le prurit :
Telfast 180mg 1cp/j le soir
- Betamethasone pmd 0.05% 1app/j pdt 7j



Molluscum contagiosum

● Clinique :

Lésion contagieuse d'origine viral

Papule perlé arrondie ombiliquée au centre de 2_5mm de diamètre, indolore, +/- prurigineuse, d'où une matière blanchâtre sort parfois à la pression

- Enfant : tronc, visage et membres
- Adulte : abdomen, pubis, génitale

✓ Traitement :

Poxkar sol 1 app 2/j pdt 4_6 semaines

Ou Molutrex ACM sol 1app 2/j pdt 14j

Jusqu'à l'apparition des signes inflammatoires (rougeur) parce qu'on ne doit pas appliquer la solution sur les lésions inflammatoires



Onychomycose

Clinique :

Infection des ongles d'origine mycologique

Les ongles sont déformés et de couleur anormale blanche ou jaune + prurit

Traitement :Adulte

- Bilan hépatique avant et après le traitement (Hépatotoxique), puis chaque 3mois

- Prélèvement mycologique

- Traitement de 3mois puis contrôle

- Garder les pieds secs

1 Loceryl sol/Mycoster 8% (vernis) 1app 2/sem le matin pdt 3mois

2 Lamidaz/Terbinafine 250mg 1cp/j pdt 3_6 mois Ou Amikoz cp 150mg 1cp/sem

3 Lamisil crème 1app 1/j le soir

■ Diabétique:

1 Fluconazole 150mg 1/sem pdt 3mois

2 Mycoster vernis 1app/j pdt 6mois

■ Si y a pas une insuffisance hépatique

■ Enfant 🧒 :

<20kg=> 1/4cp

20_40kg=> 1/2cp



Onyxis Périonyxis

● Clinique :

Inflammation de derme sous unguéal (Onyxis)

Périungueau (Périonyxis)

Rougeur + chaleur + Douleur

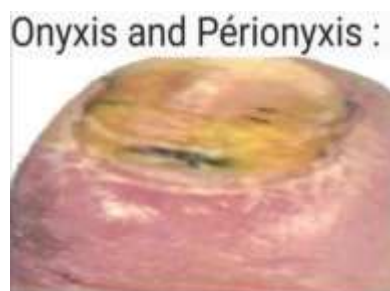
✓ Traitement :

1 Loceryl / Mycoster vernis 1 app 2/sem

2 Ketoderm (ketokonazol) crème 1 app/j

Mains=>pdt 4mois

Pieds=>pdt 6mois



Panaris

● Clinique :

Infection bactérienne du doigt

Inflammation + douleur puis abcès

✓ CAT:

■ Si stade de collection → incision sous anesthésie locale puis traitement de sortie

■ Si stade inflammatoire → Traitement

■ Laver bien au savon puis séchage

1 Fucidine pmd 1app 2/j pdt 10j

Ou Zeta pmd 1app 2/j

2 Hexomedine sol 1app 3/j

Ou Betadine bain de 10min Ou compresse imbibée 1app 3/j

3 Dolyc cp 500mg 1cp 3/j

■ Si terrain :

Lexin / Cefacet cp 1g 1cp 2/j 50mg/kg/j pdt 7j

+/_ Flagyl cp 500mg 1cp 2/j pdt 7j

■ Si échec après 48h => traitement chirurgicale

→ Orthopédie

■ Enfant 🧒 :

1 Fucidine / Zeta pmd 1app 2/j

2 Hexomedine sol 1app 2/j

+/_ Lexin/Augmentin sirop pdt 7j



Pédiculose Poux

- Éviction scolaire 1sem
 - Désinfecter les vêtements et literie 50°C
 - Appliquer lotion 2/sem puis laisser agir 30min
 - Brosser pour éliminer les poux et les lentes
 - Laver les cheveux après 6_8h avec le shampoing habituel
-
- Délice lotion >2ans
 - Marie rose lotion >3ans
 - Dermapoux sol
 - Licelock

Pédiculoses des cils

- Retrait mécanique : Extraction manuelle ou avec une pince à épiler

- Application d'une Vaseline stérile Lacryvisc 2_3/j pdt 10j

Ou Ivermectine topique pmd 1%

- Orale si sévère ou généralisé : 200ug/kg en dose unique

- À renouveler après 7j si nécessaire

 Éviter : Perméthrine, Malathion

- Contrôle après 7_10j si non réponse ou apparition d'une conjonctivite

 Avis Ophtalmologie

Piqûres d'insectes

 En urgence :

- Nettoyage au SSI
- Si réaction allergique sévère=> Inj Solumedrol 40mg

Ou HHC 100_200mg en IVD

Ou Adrénaline 1amp 0.5 en Sc Ou IV

- Si bronchospasme : O2 6l/min
Salbutamol

 Traitement de sortie :

- Antihistaminique :

 Primalan Ou Loratidine cp 10mg 1cp/j le matin

Ou Eurax crème 10% 1app 3/j jusqu'à arrêt du prurit

■CTC :

2 Celestene cp 2mg 2cp/j le matin pdt 5j

Ou Calmiderme pmd / Betasone / Locazone

+/_ Paracétamol cp 1cp 3/j

■Enfant 🍼 :

HHC 5mg/kg inj en IM ou IV

Sans dépasser 200mg en IVD

✓ Traitement de sortie :

1 Histagan sirop 1_2 cam 2_3/j

Ou Loratidine sirop

<30kg :1cam/j

>30kg :2cam/j

2 Eurax crème 1app/j le soir

LES PIQÛRES D'INSECTES



Taon



MOUSTIQUE



PUNAISE



FOURMI



ARAIGNÉE



GUÊPE



TIQUE



PUCE

+ de P'tits Trucs : comment-economiser.fr

Pityriasis rosé de Gibert

● Clinique :

Maladie inflammatoire bénigne virale
auto_limitée caractérisée par des papules ou
des plaques squameuses diffuses..

+/_ Glycémie à jeun (Dépistage de diabète)

⊖ Pas de CTC

✓ Traitement : symptomatique

- Éviter le frottement, bain chaud, savon agressif, exposition prolongée au soleil

- Douche tiède, savon surgras

1 Antihistaminique :

Deslor Ou Histagan Ou Talfast 180 le soir

Calmiderm pmd

2 Émollient ou apaisante : Cold crème

3 Vitamine C

4 Isomedine sol 1 app 3/j



Pityriasis versicolor

Clinique :

Infection mycosique de la couche la plus superficielle de la peau

Tâches squameuses et dépigmentées.

Traitement : Adulte

■ Douche chaque jour puis appliquer : sur tout le corps y compris le cuir chevelu laisser 10min puis rinçage

1 Ketokonazol 2% pmd 1app/j le soir pdt

2_4semaines

Ou Vavo ou Ketoskin

2 Mycoster spray 1app après le bain sur peau

humide pdt 1mois

3 +/- Ketokonazol gel moussant st
1 app/semaine pdt 1 mois

Appliquer sur tout le corps laisser 5min puis
rinçage

■ Si résistance au traitement local ou récurrence :
Flukas gel 150mg 1 gel/sem

■ Enfant 🧒 :

1 Ketoderm 2% crème 1 app 2_3/sem le soir
sur tout le corps y a compris le cuir chevelu
sauf les yeux

Laisser 5_10min puis rinçage

2 Mycoster spray 1 app après le bain sur peau
humide pdt 1 mois



Prurigo

● Clinique :

Prurit intense, papules érythémateuses et vésiculeuses avec lésions de grattage..

✓ Traitement :

1 Econazol crème 1app 2/j

2 Isomedine sol 1app 2/j

3 Clotasol crème 0.05% 1app/j le soir

■ Si évolution des lésions => arrêter le Clotasol



Prurit

● Origine dermatologie:

- Érythémato squameuses → Psoriasis
- Vésicules → Eczéma (adulte)/ Varicelle (Enfant)
- Papules → Gale, urticaire, dermatophytose, piquûre d'insecte
- Bulles → Pemphigoïde bulleuse

● Non dermatologie:

- IRC
- Grossesse
- Choléstase
- Dysthyroïdies
- Carence en fer
- Déshydratation

- Hémopathie maligne
- Infections VIH, HVC

- Bilan: 
- TSH
- FNS
- Glycémie
- VS/CRP
- Ferritinémie
- Hépatique: Bilirubine/Transaminases..
- Urée/Créat
- Ionogramme
- Sérologie: HIV/HBS/HCV

● Médicamenteux:

- AINS
- IEC
- Béta-bloquants
- Sartants
- Chloroquines
- Amiodarone
- Bétalactamines
- Antalgiques opiacés

Psoriasis

Clinique :

Maladie inflammatoire chronique qui s'exprime par des plaques rouges recouvertes de squames.

Traitement :

■ Psoriasis de cuir chevelu :

1 Diprosone lotion pdt 1 mois

1 app/j pdt 10j

1 app 1j/2j pdt 10j

2 Betacyl (Diprosalic) crème

1 app/j pdt 10j

1 appb1j/2j pdt 10j

3 Dexeryl sol 1 app 2/j

M2 shampooing 1 app 2/sem

■ Psoriasis de visage :

1 Betacyl

2 Dexeryl crème hydratante

■ Psoriasis du reste du corps :

1 Clotasol pmd pdt 1 mois

1 app 2/j 1^{er} semaine

1 app/j 2^{ème} semaine

1 app 1j/2j 15 derniers jours

2 Vaseline salicylée 5%

Dexerine crème hydratante 1 app 3/j

■ Psoriasis de cuir chevelu :

Douche 2/sem et éviter les huiles

Vitamine D et Mg

1 Betsol sol 1 app/j pdt 3_4sem

puis 1/2j pdt 3_4sem puis 2app/sem pdt 3_4sem

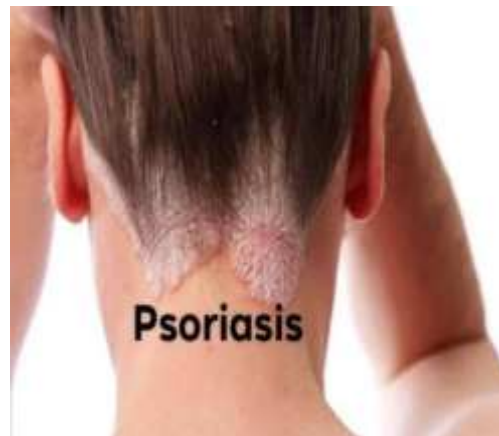
2 Ketoconazol gel

3 Ketokonazol/Vavo Shampoing 1app 2/sem pdt 1mois

Ou Dercos: crise 3_4/sem Puis 1/sem

Ou Alphacade/M2 shampoing (Pellicules)

ACM shampoing 1/sem



Psoriasis type guttata (en gouttes)

✓ Traitement :

Clotasol pmd 1app/j pdt 1sem

Puis 1app 1/2j pdt 1sem

Puis 1app 2/sem pdt 2sem

Sans dépasser 4sem



Psoriasis - «PSORIASIS» mnémotechnique

- P – Plaques (bien délimité, écailleuse)
- S – Balances argentées
- O – Sur les surfaces d'extenseur (coudes, genoux)
- R – Cours de rechute-remitting
- I – Lésions qui démangent
- A – Signe Auspitz (saignement de point quand les écailles sont éraflées)
- S – Associations systémiques (arthrite, syndrome métabolique)
- I – Base immunologique (auto-immune, médiée par les lymphocytes T)
- S – Streptococcal infection trigger (Guttate psoriasis)

Rosacée

● Clinique :

Couperose maladie cutanée incurable au départ bénigne qui se manifeste par des rougeurs chroniques au niveau du nez, des joues, parfois aussi au niveau du menton et du front, picotements ++

✓ Traitement :

1 Dexeryl crème hydratante

2 Rosax pmd

3 Écran total

4 +/- Acide salicylique crème de la roche posay pour visage



Scarlatine

Clinique :

- Angine rouge en flamme érythémateuse ou érythémato pultacée, fièvre, Strepto +++
- Douleur abdominale, vomissements, ADP
- Exanthème généralisée maculopapuleux en nappe sans intervalle de peau saine respectant la région péri buccale
- Langue : V lingual puis framboisée décapillée
- Test rapide TDR
- Déclaration obligatoire
- Eviction scolaire 15j

Traitement :

- ATB : Amoxicilline Ou Augmentin Ou Peni V
- Antipyrétique
- BU au j3



Teignes

Clinique : Ténia capitis

Régions kératinisées du corps caractérisées par des plaques arrondies croissant de leur centre vers leur périphérie avec une peau changeant d'aspect et de couleur, et disparition des poils ou cheveux dans certains cas.

 Traitement : Adulte toujours per os +/- local

 1 Lamisil cp 250mg 1cp/j

Ou Griseofulvin cp 250/500mg 1cp 2/j

 2 Lamisil crème 1% 2app/j pdt 4sem

Ou Mycoster spray 1app 2/j

 3 Shampoing Vavo 1app 2/sem 2flc

 4 Betadine sol 1app/j

Ou

1 Itraconazol 6mg/kg/j

Itraconyx 100mg 1gel/j pdt 6_8sem

2 Tinasil spray ou Terbidal

⚠ Pas de DermoCTC : Risque d'alopécie définitive cicatricielle

Si c'est un teigne inflammatoire : CTC per os

Solupred 1mg/kg pdt 10j

■ Femme enceinte 🤰 :

1 Shampoing Vavo

2 Ketoskin pmd 2%



■ Enfant 🧒 :

1 Ketokonazol crème 1 app 2/j pdt 28j

Ou Lamisil crème 1% 1 app/j pdt 4sem

2 Vavo Shampoing 3app/sem

+/_ Griseofulvin 20mg/kg/j

■ Si Résistance : 2_4sem

Terbinafine cp 250mg cp sécable

10_20kg=>62.5mg/j

21/40kg=>125mg/j

>40kg=>250mg/j

■ Éviction scolaire

■ Photoprotection

■ Raser les cheveux autour

■ Bilan hépatique au cours du traitement

■ Si échec du traitement => faire un prélèvement

Teignes type Trichophytique

- Prélèvement mycologique pour confirmer le diagnostic
- Bilan hépatique: TGO et TGP avant et après le traitement

 Traitement:

 1 Terbinafine cp 1ddp 1/j pdt 4sem

- Selon le poids
- 10_20kg: 65mg 1/4cp 250mg
- 20 a 40kg: 125mg 1/2cp 250mg
- >40kg: 1cp 250mg/j

Ou Itraconazol 6mg/kg/j 100mg 1gel/j pdt 6_8sem

(Pout toute type de teigne)

2 Terbidal/Tinasil spray 2pul 2/j sur des lésions

3 Vavo shampooing 1app 2/sem

⊖ Pas de CTC sauf si teigne inflammatoire:

Solupred 1mg/kg pdt 10j per os



Ulcère de la jambe

 Hospitalisation

- Bilan complet : 
- FNS
- Gly à jeûne
- HBA1C
- Urée/Créat
- Lipidique
- CRP/VS
- Ionogramme
- Dextro
- Glycémie veineuse
- CDU

- Prélèvement avec ECB
- Antibiogramme
- IPS

- Rx
- Échodoppler des 2 MI
- Échographie des parties molles

✓ Traitement :

- Réhydratation
- ATB à large spectre
- Fucidine pmd
- Antalgique
- Vaccin AT
- Soins locaux : au SSI
- Pansement absorbant

→ Avis Chirurgie vasculaire

Urticaire

Clinique :

Dermatose inflammatoire marquée par un œdème dermique ou dermo-hypodermique

Eruption cutanée érythémateuse et papuleuse dont les lésions sont typiquement fugaces, migratrices et prurigineuses

Contours réguliers, reliefs bombés, tailles différentes

■ Bilan :  Si chronique >6sem

■ Ac antiTPO

■ FNS

■ CRP

 Traitement : Adulte

 En urgence : Phenergan 1amp en IM

Ou HHC Max 200mg

■ Traitement de sortie :

Telfast cp 180mg 1cp/j le soir

Ou Xycare 1cp le soir

Ou Zyrtec gtt 20gtt le matin si enfant 10gtt

Ou Totinal cp 1cp/j le soir

■ Enfant 🧒 :

⊖ Si œdème : palpébral ou des lèvres

HHC 5mg/kg en IVD Max 100mg

Si pas de réponse => à renouveler !

Si pas de réponse => Adrénaline !!

◆ >6ans : même que adulte

◆ <2ans : Primalan sirop 1cac/j le soir

◆ Polaramine ou Histagan sirop 1cam pour 10kg

◆ Zyrtec >2ans :

2_6ans : 5gtt 2/j

6_12ans : 10gtt 2/j

>12ans : 20gtt 1/j

■ Si chronique >6 semaines :

➡ Avis dermatologie



Verrues

✓ Traitement :

1 Verulyse/Verrucare/Collomak/Duofilm/Corn ex pmd 1_2app/j pdt 1mois

Ou Vaseline salicylée 10% 1app/j le soir

2 Vaseline blanche en périlésionelle Pdt 1mois

▪ Si non => Cryothérapie par l'azote liquide

▪ Enfant 🧒 :

URGO coricide après un bain chaud sans déborder sur la peau saine



Verrues plantaire en mosaïque

✓ CAT :

- Changer les chaussures
- Chaussures orthopédiques
- Laver bien les lésions par un savon de soufre puis sécher puis app le traitement :

1 Vaseline salicylée 10_20% 2/j pdt 1 mois

2 Infectoban pmd 2% 2/j

3 Hexomedine sol



